

ملخص جدول أعمال البحث والعمل الإقليمي:

شمال إفريقيا وغرب آسيا

الموجز التنفيذي

ربط العقلية المناخية (CCM) هي مبادرة ممولة من مؤسسة (Wellcome) تهدف إلى تنمية مجال تعاوني متعدد التخصصات لتغيير المناخ والصحة النفسية برؤية واضحة ومتسقة. وقد قمنا بدعوة خبراء من مختلف التخصصات والقطاعات والبلدان على مدار العام الماضي، لتطوير جدول أعمال البحث والعمل الإقليمي والعالمي. تحدد جداول الأعمال هذه ما يلي: (1) أولويات البحث لفهم ومعالجة احتياجات الأشخاص الذين يعانون من عبء أزمة المناخ وتأثيرها على الصحة النفسية، (2) الأولويات لتمكين هذا البحث والاستخدام الأدلة لتشجيع المبادرات في المجال السياسي والعملية. يلخص هذا التقرير جدول أعمال البحث والعمل بشأن تغيير المناخ والصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا (NAWA) - وهي منطقة يشار إليها غالباً باسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ويشار إليها في هذه الوثيقة باسم شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)؛ وقد تم نشر جدول الأعمال الكامل¹ بشكل منفصل وهو متاح [هنا](#).

حدد مشروع ربط العقلية المناخية (CCM) عدداً من المحاور البحثية ذات الأولوية لمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) والتي تغطي المجالات التالية:

- استكشاف تأثيرات تغيير المناخ على الصحة النفسية والمسارات التي تحدث من خلالها تلك التأثيرات: يجب أن تحلل الأبحاث طبيعة وشدة آثار تغيير المناخ على نتائج الصحة النفسية. ومن المهم استكشاف المسارات البيولوجية النفسية الاجتماعية التي تربط تغيير المناخ بتحديات الصحة النفسية، بما في ذلك تلك الأكثر انتشاراً في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
- تحديد الفئات الأكثر تضرراً: يجب أن تحدد الأبحاث المجموعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغيير المناخ على الصحة النفسية. بالنسبة إلى منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، يشمل ذلك دراسة التأثيرات على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وغيرهم من الفئات السكانية المعرضة للخطر.
- فهم التأثيرات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA): يجب أن تستكشف الأبحاث التأثيرات الإقليمية المحددة لتغيير المناخ على الصحة النفسية. ويشمل ذلك دراسة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف البلدان والمناطق الجغرافية (مثل المجتمعات الساحلية أو الحضرية) والسكان وتحديد التدخلات الخاصة بالمنطقة لمعالجة تلك التحديات والتي تكون تراعي الاحتياجات الثقافية المحلية.
- استكشاف أوجه التآزر بين تغيير المناخ وسياسات الصحة النفسية، وخاصة بالنسبة إلى الفئات السكانية المعرضة للخطر: يجب أن تركز الأبحاث على دمج اعتبارات الصحة النفسية في سياسات واستراتيجيات تغيير المناخ والعكس بالعكس. ويشمل ذلك تقييم فعالية التدخلات السياسية في حماية الصحة النفسية وتعزيز القدرة على تحمل تغيير المناخ.
- فهم فوائد الصحة النفسية للإجراءات والتدخلات المناخية: يجب أن تستكشف الأبحاث الفوائد المشتركة للتكيف مع تغيير المناخ وإجراءات التخفيف من آثار حدة تغيير المناخ على الصحة النفسية (على سبيل المثال، الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الخضراء).
- تقييم إمكانات الوصول إلى خدمات الصحة النفسية: يجب أن تدرس الأبحاث إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة النفسية أثناء الأزمات المرتبطة بالمناخ. ويشمل ذلك تقييم مدى توفر التدريب على الإسعافات الأولية النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتقييم مدى استعداد مرافق الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الصحة النفسية أثناء الأحداث المتعلقة بالمناخ.

إن تحقيق تقدم ملموس يتطلب قيادة مخصصة وموارد وإرادة سياسية إلى جانب المشاركة المستدامة والشاملة من جميع قطاعات المجتمع. وتسعى هذه الوثيقة إلى الإلهام من خلال إظهار الإمكانيات إذا استفدنا بشكل جماعي من المعرفة والتكنولوجيا والسياسة ونقاط القوة المجتمعية لمعالجة آثار تغيير المناخ على الصحة النفسية. ويستلزم المسار للمضي قدماً التغلب على العقبات المعقدة وإجراء تحولات في النظام والتي تتطلب جهداً متواصلاً. ومن خلال اتخاذ خطوات أولى طموحة تركز على التفاوض المتعاطف، يمكننا أن نمضي قدماً نحو مستقبل حيث يتم تقدير صحة الأفراد والكوكب على حد سواء، ويُنظر إليهما على أنهما مترابطان.

المقدمة

المخاطر المناخية في شمال إفريقيا وغرب آسيا

تواجه منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) زيادة في تواتر وشدة مجموعة من المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يلي، وضعت نماذج عام 2030 تقريباً مقارنة بخط الأساس التاريخي (من عام 1986 - 2005 بشكل عام):^{2، 3}،

- حرارة شديدة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشهد ليبيا ومصر، خصيصاً، زيادة تصل إلى أكثر من 20 يوماً حاراً إضافياً سنوياً (بدرجة ثقة عالية)؛ⁱⁱ
- حالات الجفاف وحرارة الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا (بدرجة ثقة منخفضة إلى متوسطة)؛
- أحداث هطول أمطار غزيرة وفيضانات، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في مصر والسودان ومنطقة الساحل والصحراء وشبه الجزيرة العربية (بدرجة ثقة عالية)؛ الفيضانات المطرية فوق منطقة الساحل والصحراء (بدرجة ثقة عالية) وشبه الجزيرة العربية (بدرجة ثقة متوسطة)؛ والفيضانات الساحلية في جميع أنحاء المنطقة (بدرجة ثقة عالية).
- ارتفاع مستوى سطح البحر حول إفريقيا، مما يساهم في زيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية في المناطق المنخفضة وفي تآكل السواحل على طول معظم الشواطئ الرملية (بدرجة ثقة عالية).

تغير المناخ والصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)

الأبحاث الموجودة حالياً

لا توجد حالياً أبحاث كافية حول تأثيرات تغير المناخ على الصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تأثير مخاطر تغير المناخ، مثل موجات الحر، على القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، وكيف يمكن أن تؤثر تلك التأثيرات على الصحة النفسية للفئات المعرضة للخطر. ويمكن العثور على ملخص موجز للمواد المطبوعة للأدبيات الحالية في الملحق.

نتائج مشروع ربط العقلية المناخية

تُعرض الأقسام التالية نتائج مشروع ربط العقلية المناخية (CCM) - بما في ذلك تحديد النطاق قبل الحوار، وحوارين، واستقصاءين ومشاورات الخبراء (راجع الملحق للحصول على تفاصيل حول الأساليب) - للاستكشاف: تصورات مخاطر الصحة النفسية المرتبطة بالتعرض لمخاطر التغير المناخي؛ الذين قد تكون صحتهم النفسية أكثر عرضة للخطر؛ والمسارات التي قد يؤدي التعرض لتغير المناخ من خلالها إلى إنتاج أو تفاقم تحديات الصحة النفسية الحالية. يرجى ملاحظة أن الملخصات في الأقسام التالية هي تقارير أو تصورات من خبراء متنوعين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم خبرة عملية، وليست مستمدة من الأدلة المنشورة.

ما هي نتائج الصحة النفسية التي يبدو أنها تتأثر؟

تبادل المشاركون في الحوار مجموعة من تحديات الصحة النفسية الناشئة عن تغير المناخ، والتي تم التعبير عنها بأعراض الصحة النفسية المذكورة أدناه:

- **"الخوف والذعر أثناء الأحداث المناخية"**، وهي شبيهة باضطراب الإجهاد الحاد، والشعور بالإرهاق من التهديدات المباشرة والآثار طويلة المدى. وقد تفاقم هذا بسبب "الإرهاق الناتج عن التغير اليومي والحرارة والجفاف"، وهو ما شبيهه بالإجهاد المزمن، الذي لا يؤثر على الصحة النفسية

ⁱ تستند التوقعات المستقبلية إلى سيناريو انبعاثات منتصف الطريق (المسار الاجتماعي والاقتصادي المشترك الإصدار 2 حتى 4.5 (4.5-2SSP)) من مشروع المقارنة بين النماذج المقترنة الإصدار السادس (6CMIP) المقدمة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2021. ⁱⁱ تعتبر مستويات الثقة المدرجة بعد التوقعات مقياساً لثقة الباحث في أن نتائج النموذج صحيحة وليست نتيجة للصدفة.

فحسب، بل يؤثر أيضاً على الجوانب الملموسة من الحياة مثل توفر الغذاء وأسعاره، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغوطات على الصحة النفسية.

- **"العجز وقلة الحيلة"**، حيث يشعر الأفراد "بالبأس والخوف بشأن المستقبل" بسبب حجم التحديات البيئية وانعدام السيطرة على الأحداث المتعلقة بالمناخ، وغالباً ما تعكس التأثيرات المبلغ عنها على حياتهم أعراض الاكتئاب.
- **القلق بشأن المناخ**، الذي يشبه اضطراب القلق العام حسب الأعراض الموصوفة، كقوة تؤدي إلى شلل الأفراد بشكل مجازي ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بعدم الجدوى من الأنشطة اليومية والأهداف طويلة المدى. ومن الجدير بالذكر أن المخاوف بشأن "الأمن الغذائي بسبب الظروف الجوية القاسية" و"الخوف على الدخل المستقبلي ومكان العيش" رسمت صورة للقلق السائد الذي يمتد إلى مختلف جوانب الحياة، مما أدى لتحفيز الاستجابة النفسية التي تكون انعكاساً ورد فعل على التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على المجتمع والأجيال القادمة. ومع ذلك، لوحظ أيضاً أنه بالنسبة إلى البعض، يمكن أن يتحول هذا القلق إلى "حافز إيجابي"، على غرار مفهوم النمو بعد الصدمة النفسية، مما يحفز العمل والمشاركة في الحلول المناخية.

من الذي يبدو أنه يتأثر بشكل خاص بتأثيرات تغير المناخ على الصحة النفسية؟

- المجتمعات الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والتآكل والفيضانات
- السكان النازحون والمهاجرون
- كبار السن والأطفال
- الأفراد الذين يعانون من حالات الصحة النفسية الموجودة لديهم مسبقاً
- المجتمعات الريفية / الزراعية
- الفئات المهمشة اجتماعياً ذات الموارد أو أنظمة الدعم المحدودة

ما هي المسارات والآليات التي تربط هذه المخاطر المناخية بنتائج الصحة النفسية؟

حدد المشاركون العديد من المسارات والآليات الحاسمة التي تربط المخاطر المناخية بنتائج الصحة النفسية والتي تشمل:

- التأثير على سبل العيش: حيث يؤدي التصحر وارتفاع درجات الحرارة إلى تقويض الاستقرار المالي للعمال والمزارعين، مما يؤدي إلى زيادة محتتهم.
- انعدام الأمن الغذائي والمائي: حيث يمكن أن يؤثر انعدام الأمن الغذائي ونُدرة المياه على الصحة النفسية، خاصة في المجتمعات الزراعية، بسبب الإجهاد النفسي البدني المرتبط بالحصول على المياه والتهديدات اللاحقة للتغذية.
- النزوح: تؤدي حركة السكان بسبب الأحداث المتعلقة بتغير المناخ وعواقبها إلى تفاقم تحديات الصحة النفسية مثل الإجهاد والاكتئاب.
- العزلة الاجتماعية نتيجة الحرارة الشديدة: إن حبس الأفراد في منازلهم والعزلة الاجتماعية بسبب الحرارة الشديدة يزيد بشكل كبير من انتشار التوتر والقلق المرتبط بالحرارة وغيرها من تحديات الصحة النفسية.
- الوعي المناخي: إن زيادة الوعي بشأن تغير المناخ، بما في ذلك القلق بشأن الأحداث المناخية المستقبلية، يدل على كيف يمكن للضغط الاستباقي والقلق بشأن الكوارث المرتبطة بالمناخ التي تنتظرنا أن يؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية.

جدول أعمال البحث

المحاور البحثية ذات الأولوية

يقدم جدول الأعمال البحثي هذا رؤية متناسقة لإرشاد مجال المناخ والصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA). وقد تم وضع أولويات البحث من خلال التشاور مع الخبراء في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق الجغرافية في المنطقة وتكرارها مع الخبراء على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ وهي معروضة ضمن أربع فئات بحثية شاملة تم تحديدها كمجالات ذات حاجة ماسة لمزيد من العمل على الصعيد العالمي، واستناداً إلى مراجعة أولية للأدبيات (انظر الملحق لمزيد من التفاصيل). وتمثل محاور البحث ذات الأولوية المجالات التي يمكن أن يؤدي الاستثمار البحثي المستهدف فيها إلى تكوين صورة كاملة عن التأثيرات والآليات والحلول عبر إجراءات الصحة النفسية والمناخ.

فئة البحث	محور البحث ذو الأولوية
الآثار والمخاطر والفئات الضعيفة	1. استكشاف طبيعة وانتشار تحديات الصحة النفسية التي يواجهها السكان في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) بسبب تأثيرات درجات الحرارة القصوى، بما في ذلك بلوغ درجات الحرارة لـ 50 درجة مئوية، أو موجات الحر، وتقييم استراتيجيات التصدي لهذه التحديات على المدى القصير.
	2. فهم كيفية تأثير التعرض لموجات الحر ودرجات الحرارة القصوى على الصحة النفسية للفئات السكانية الضعيفة، مثل كبار السن والأطفال والأفراد الذين يعانون من حالات صحية نفسية موجودة لديهم مسبقاً، وما هي التدخلات التي يمكن أن تعالج تلك التحديات في المجتمعات المتضررة.
	3. تحديد عواقب الصحة النفسية التي يعاني منها السكان في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) بسبب الآثار المضاعفة للمخاطر المرتبطة بالمناخ (على سبيل المثال، مزيج من زيادة الجفاف ونقص الكهرباء ودرجات الحرارة القصوى).
	4. فهم إلى أي مدى من المحتمل أن يؤدي تغير المناخ (على سبيل المثال، من خلال الفيضانات الأكثر تواتراً) إلى زيادة انتشار اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بين الأطفال والمراهقين في المناطق الداخلية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وتصميم استراتيجيات للاستجابة لهذه الزيادة.
	5. استكشاف العواقب المحتملة على الصحة النفسية على المدى الطويل لآثار الأخطار المرتبطة بتغير المناخ على محدثات الصحة النفسية - مثل فقدان سبل العيش أو زيادة أوجه عدم المساواة الاجتماعية - على السكان المهمشين في بلدان شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) على مدى السنوات العشر المقبلة.
	6. فهم كيفية مساهمة النزوح الناجم عن المناخ والهجرة القسرية في تحديات الصحة النفسية بين السكان المتضررين في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
	7. فهم كيف تؤثر الهجرة المختارة الناجمة عن العوامل المرتبطة بتغير المناخ داخل بلدان منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) وفيما بينها على تحديات الصحة النفسية والرفاه النفسي للأفراد والمجتمعات وما إذا كانت هناك عواقب نفسية دائمة لهذه الهجرة.
	8. استكشاف كيفية تأثير تغير المناخ على الصحة النفسية للأفراد الذين يعتمدون على الزراعة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، لا سيما من خلال التغيرات في إنتاجية المحاصيل والأمن الغذائي وسبل العيش.
	9. فهم التأثير المتوقع لتغير المناخ على الصحة النفسية للمجتمعات الساحلية في بلدان شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة مخاطر الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر على مدى السنوات العشر القادمة.

1. فهم المفاهيم الثقافية المختلفة للاكتئاب (إضافة إلى تحديات الصحة النفسية الأخرى) في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) مقارنة بالمنظورات الغربية، وكيفية ارتباط هذه التفسيرات بتحديات الصحة النفسية في سياق تغير المناخ. واسترشاداً بهذه المفاهيم، وتحديد التدخلات المراعية للثقافات التي تدعم الصحة النفسية على أفضل وجه في مواجهة المخاطر المناخية.
 2. تحديد الآليات التي تؤدي من خلالها موجات الجفاف المطولة وندرة المياه إلى تحديات الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وتحديد تدخلات الصحة النفسية، فضلاً عن تقنيات إدارة المياه المبتكرة للتخفيف من تلك الآثار.
 3. فهم ما إذا كان فقدان الهوية والانفصال الثقافي يؤثران على العلاقة بين التصحر / تدهور الأراضي وتدهور الصحة النفسية بين مجتمعات الشعوب الأصلية.
 4. استكشاف عزلة الأفراد في منازلهم بسبب الحر الشديد وما ينتج عنه من عزلة اجتماعية وتعطيل للأنشطة الخارجية (مثل ممارسة الرياضة) كمسارات محتملة تؤدي من خلالها الحرارة الشديدة إلى تفاقم نتائج الصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
 5. فهم المسارات والآليات التي قد تؤثر من خلالها زيادة الوعي بتغير المناخ على نتائج الصحة النفسية (على سبيل المثال، من خلال زيادة القلق والمخاوف والتوتر الاستباقي بشأن الأحداث المناخية المستقبلية والكوارث المرتبطة بالمناخ). ويشمل ذلك تمييز ما إذا كانت جوانب معينة من "القلق بشأن المناخ" هي مظهر آخر من مظاهر اضطراب القلق العام أو ما إذا كان القلق بشأن المناخ له جوانب محددة وجديدة.
 6. رسم خريطة للمسارات البيولوجية النفسية الاجتماعية المحتملة الأخرى التي يؤثر من خلالها تغير المناخ على الصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، واستكشاف مدى صلاحيتها وتحديد أهداف التدخل في تلك المسارات.
-
1. فهم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والصحية النفسية المشتركة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الخضراء في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وكيف يمكن تحسين تلك المنافع المشتركة لتحسين نتائج الصحة النفسية، خاصة في المجتمعات المهمشة.
 2. استكشاف كيف ينظر مختلف أصحاب الشأن - بما في ذلك صانعو السياسات ومقدمو الرعاية الصحية والمجتمعات المحلية - إلى كيفية دمج استراتيجيات التكيف والتخفيف من حدة تغير المناخ ومبادرات الصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وفهم كيفية معالجة هذه التصورات لتسهيل الدمج الفعال.
 3. فهم دور المعارف التقليدية وممارسات السكان الأصليين في التدخلات المتعلقة بالتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه والتي لها فوائد مشتركة للصحة النفسية، وكيفية دمج تلك الممارسات في تطوير مناهج تراعي الثقافة لاستراتيجيات تعزيز الصحة النفسية للمجتمعات المتنوعة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
 4. تحديد التدخلات الأكثر فعالية والقائمة على الأدلة "الأفضل اقتناءً" لمعالجة تحديات تغير المناخ والصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA). مع تقييم الكيفية التي تؤثر بها أطر السياسات وهياكل الحوكمة على تنفيذ تلك التدخلات وقابلية توسيع نطاقها وتحديد توصيات السياسات التي تعزز إدماج تلك التدخلات في جداول الأعمال الوطنية.
 5. تحديد التدخلات الأكثر فاعلية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز نتائج الصحة النفسية في مختلف البيئات في آن واحد، مع مراعاة عوامل مثل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية والوضع الاجتماعي والاقتصادي والاختلافات الثقافية.
-
1. تطوير وتنفيذ وتقييم التدخلات المجتمعية لتلبية احتياجات الصحة النفسية للأفراد المتضررين من الأخطار المرتبطة بتغير المناخ، مثل الظواهر الجوية المتطرفة أو انعدام الأمن الغذائي، في بلدان شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) خلال السنوات الخمس المقبلة.

فوائد الصحة النفسية
للإجراءات المتعلقة
بالمناخ (التكيف والتخفيف
من حدة تغير المناخ)

تدخلات الصحة النفسية /
الحلول في سياق تغير
المناخ

2. فهم إلى أي مدى تخفض التدخلات المجتمعية من نسبة الفوارق في مجال الصحة النفسية وتعزز القدرات على التكيف مع المناخ المتغير بين المجموعات الفرعية الديموغرافية (مثل الشباب وكبار السن والنساء) في مختلف بيئات منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وتحديد الآليات الأساسية لفعاليتها.
3. فهم الكيفية التي تبني بها التدخلات المصممة ثقافياً القدرة على الصمود في مجال الصحة النفسية وتسهيل استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ بين الفئات السكانية الضعيفة في بلدان شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) وتحديد العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح تلك التدخلات.
4. استكشاف سبل تسخير التقنيات الرقمية المبتكرة ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز وصول وفعالية التدخلات التي تعالج كلاً من تغير المناخ والصحة النفسية، لا سيما بين السكان الشباب في المناطق الحضرية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
5. تقييم التدخلات المستهدفة في مجال الصحة النفسية ومبادرات العمل المناخي لتخفيف أعباء الصحة النفسية لأولئك الذين يواجهون النزوح بسبب عوامل تتعلق بالمناخ.
6. تحديد الفجوات في قدرات القوى العاملة في الصحة النفسية لمعالجة التحديات المتعلقة بالصحة النفسية الناجمة عن المناخ في مناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
7. تحديد أكثر البرامج فعالية في مجال التدريب وبناء القدرات للقوى العاملة في الصحة النفسية لمعالجة آثار تغير المناخ على الصحة النفسية واستكشاف كيفية توسيع نطاق هذه الممارسات وتكرارها.
8. فهم كيف يمكن للمؤسسات التعليمية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) أن تدمج تحديات الصحة النفسية المرتبطة بالمناخ في المناهج الدراسية وبرامج تدريب أخصائيي الصحة النفسية وما إذا كان الخريجون مستعدين بشكل كافٍ لمواجهة تحديات الصحة النفسية المرتبطة بالمناخ.
9. فهم كيفية دمج ممارسات الشفاء التقليدية وممارسات الشفاء لدى السكان الأصليين في برامج تدريب أخصائيي الصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وتعزيز كفاءتهم الثقافية وتمكينهم من دعم المجتمعات التي تتعامل مع تحديات الصحة النفسية المرتبطة بالمناخ بفعالية.
10. تقييم استراتيجيات توظيف القوى العاملة في مجال الصحة النفسية وتدريبها والاحتفاظ بها - مثل الأطباء النفسيين وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين - للاستجابة لتأثيرات الصحة النفسية المرتبطة بالمناخ على المجتمعات المتنوعة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
11. تقييم الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز التعاون بين التخصصات والقطاعات ذات الصلة - مثل أخصائيي الصحة النفسية وعلماء البيئة وقادة المجتمع وصانعي السياسات - من أجل التصدي بفعالية لتحديات الصحة النفسية المرتبطة بالمناخ في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
12. تقييم (1) كيفية مساهمة التقنيات الرقمية وتدخلات الرعاية الصحية عن بُعد في بناء قدرات القوى العاملة لتقديم خدمات الصحة النفسية في المناطق النائية والهشة المتأثرة بتغير المناخ في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، و(2) تقييم التحديات والفرص المرتبطة بتطويرها وتنفيذها.
13. فهم دور المنظمات المجتمعية والوكالات غير الحكومية في تعزيز قدرة القوى العاملة في مجال الصحة النفسية على الاستجابة لتحديات الصحة النفسية المرتبطة بالمناخ في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وكيفية تنسيق هذه الجهود بفعالية مع المبادرات الحكومية.

جدول الأعمال

يسعى هذا البرنامج إلى تحديد رؤية مشتركة باعتباره محوراً حاشداً لمجال الصحة النفسية والتغير المناخي في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA). ويسعى لمواجهة التحديات التي يجب معالجتها، والاستفادة من الفرص المتاحة وتحديد الإجراءات ذات الأولوية للعمل لأجل بيئة مناخية مزدهرة لمجال الصحة النفسية.

الرؤية الإقليمية لمجال الصحة النفسية في بيئة متغيرة

تتضمن رؤيتنا لمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) أن تكون الترابطات بين التغيرات المناخية والصحة النفسية مفهومة على نطاق واسع وأن يتم دمجها في السياسات والممارسات. وأن يتاح للمجتمعات التي تواجه خطر التغير المناخي في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) الموارد والأنظمة الداعمة لحماية صحتهم العقلية والنفسية ولتعزيز القدرة على التحمل والمواظبة.

أنشاء بيئة مواتية للأبحاث واستخدام أساس قوي من الأدلة لتشجيع المبادرات

ترجمة قاعدة الأدلة المتزايدة إلى إجراءات يمكنها الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ على الصحة النفسية	خلق بيئة مواتية للأبحاث في نقاط التداخل بين تغير المناخ والصحة النفسية	
● عدم التنسيق بين القطاعات ● محدودية التمويل للأبحاث التي تركز على تطبيق الحلول ● الشكوك حول تغير المناخ، والتي تعيق أن يكون هناك إرادة سياسية ● وصمة العار المتعلقة بالصحة النفسية، والتي تعيق الحوار المفتوح وسلوكيات طلب المساعدة ● قلة الوعي العام عن الروابط بين تغير المناخ والصحة النفسية لجذب انتباه صانعي السياسات واتخاذ الإجراءات السريعة ● الأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء وقلة القدرة على وضع مسائل أخرى في الاعتبار ● الإرهاق بين الممارسين العاملين مع المجتمعات المنكوبة	● قلة المقاييس المخصصة للإقليم ● قلة الموارد والتمويل بما يتماشى مع نقاط الضعف بالمنطقة ● وصمة العار المرتبط بالصحة النفسية ● قلة الوعي بين المختصين وعامة الشعب بما يخص مشكلة تغير المناخ والصحة النفسية ● عدم وجود مجموعات بيانات محدثة ● التعقيدات والمشاكل السياسية التي تؤثر وتعرق الجهود المبذولة في تطبيق الحلول ● المقاومة الثقافية والأيدولوجية للتغيير ● عدم وجود توافق في وجهات النظر بين المتعاونين	التحديات
● شبكات المجتمع المدني القوية والتي توفر أسس للعمل الشعبي والدعم الاجتماعي ● زيادة وعي ومخاوف الشباب اليافعين فيما يخص المناخ والصحة النفسية من أجل التشجيع على التغيير ● تسهيل الوصول للتكنولوجيا والحلول الإلكترونية للصحة النفسية وتقديم تدخلات قابلة للتطوير ● الالتزامات الإقليمية مثل إطار ساندي (Sanadi) في العراق، والذي يظهر قابلية التطور ● على الرغم من مدى سوء الأزمات الجارية، إلا أنها تتيح دافعاً للتغيير إلى الأفضل من خلال الجهود المبذولة في إعادة البناء	● زيادة الوعي بالعلاقة بين المناخ والصحة النفسية والحاجة إلى البحث في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي ● استدامة مجتمع الممارسات الإقليمية بمشروع ربط العقلية المناخية لإفادة وتمكين البحوث المستقبلية ● التعاون مع الجامعات لوضع المناخ والصحة النفسية في المناهج الدراسية	الفرص وعوامل التمكين
● الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارات الصحة والبيئة والتعليم	● مجموعة متنوعة من شركاء الأبحاث الذين يشملون تخصصات متعددة:	الشركاء المحتملون

● الأنظمة الصحية	○ علم المناخ
● الوكالات الحكومية الدولية، بما في ذلك المكاتب الإقليمية	○ علم البيئة
● لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة	○ علم الأوبئة
● المؤسسات الإعلامية، وخاصة تلك التي تبث بلغات متعددة عبر مختلف البلدان	○ السياسة والحوكمة
● المنظمات غير الحكومية، مثل جمعيات الهلال الأحمر	○ علم النفس والطب النفسي
● الشركات الخاصة	○ الصحة العامة
● الجامعات والمؤسسات الأكاديمية	○ العلوم الاجتماعية
	● المنظمات الدولية، مثل اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية
	● أصحاب الشأن والمنظمات المحلية
	○ المراقبون
	○ زعماء المجتمعات المحلية
	○ المدارس / الجامعات
	○ المجموعات النسائية
	○ الشباب اليافعون
	● أصحاب الشأن والمنظمات الوطنية، بما في ذلك الوزارات الحكومية

الخطوات التالية / التوصيات ذات الأولوية للمستثمرين والجهات الفاعلة

خلق بيئة مواتية للبحث في نقاط التقاطع بين تغير المناخ والصحة النفسية

سيطلب تنفيذ جدول الأعمال البحثي هذا اتباع نهج متعدد التخصصات بالتعاون بين أصحاب الشأن. تشمل الخطوات التالية ذات الأولوية للمستثمرين والجهات الفاعلة في المنطقة ما يلي:

- **إنشاء واستدامة شبكة إقليمية للمناخ والصحة النفسية:** استخدام منصة مشروع ربط العقلية المناخية كأساس للجمع بين أصحاب الشأن والمختصين والمجتمعات. ومن شأن هذه المنصة أن تعمل على تسهيل تبادل المعرفة وجهود بناء القدرات، وتبسيط الوصول إلى فرص التمويل لأولويات البحث والعمل المحددة، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير استراتيجيات إقليمية مصممة خصيصاً للتحديات والفرص الفريدة داخل منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).
- **ضمان الالتزام من أصحاب الشأن الرئيسيين:** إشراك الجهات الفاعلة الوطنية والمنظمات الدولية والوزارات الحكومية للالتزام باستراتيجية موحدة تعطي الأولوية للصحة النفسية في سياق تغير المناخ. وينطوي ذلك على إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات وتأمين التمويل لبرامج البحث والتدخل.
- **تطوير التدخلات البحثية والسياسية والمشاريع التي تتناول العلاقة بين المناخ والصحة النفسية:** الاستثمار في جهود بناء القدرات لتوفير الأفراد والمنظمات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم التدخلات التي تعالج المناخ والصحة النفسية. إطلاق مشاريع تجريبية تمثل النهج المتكامل لتغير المناخ والصحة النفسية. ويجب أن تركز هذه المشاريع على المجالات الحيوية، مثل تعزيز مرونة المجتمع، وتطوير تدخلات الصحة النفسية الحساسة ثقافياً، وتنفيذ سياسات بيئية مستدامة.

ترجمة قاعدة الأدلة المتزايدة إلى إجراءات يمكنها الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ على الصحة النفسية

ينبغي لوضع السياسات:

- الاعتراف بالروابط المتبادلة بين الصحة النفسية وتغير المناخ التي حددتها خطة البحث والمبادرة الإقليمية لمشروع ربط العقلية المناخية ضمن السياسات الوطنية الصحية والبيئية.
- تقييم نقاط الضعف المناخية بالنظام بما في ذلك تأثيرات الصحة النفسية المرتبطة بالمناخ.

ينبغي لهيئات التمويل:

- تخصيص الموارد لتنفيذ الأبحاث وتطوير المقاييس المتعلقة بتغير المناخ والصحة النفسية.
- الاستثمار في تعليم القوى العاملة وتدريبها لتوسيع نطاق التدخلات التي تستجيب لتأثيرات تغير المناخ على الصحة النفسية.

يجب على المؤسسات البحثية والأكاديمية:

- إجراء الأبحاث لتحديد الفجوات في تقديم الخدمات.
- تعزيز منصات الشراكات بين القطاعات وتبادل المعرفة.

يجب على أصحاب الشأن والمنظمات المجتمعية:

- إعداد حملات لمعالجة الشكوك المناخية والعار المتعلق بالصحة النفسية وزيادة الوعي بالروابط الهامة بين تغير المناخ والصحة النفسية في المنطقة.
- التعاون مع المدارس والجامعات لدمج تغير المناخ والتثقيف في مجال الصحة النفسية في المناهج الدراسية.
- توفير الوعي المناخي والصحة النفسية وبناء القدرات لأولياء الأمور والعائلات.

الختام

يمثل جدول الأعمال البحثي والعملي هذا خطوة أولية حاسمة في تطوير مناهج معالجة تحديات الصحة النفسية المتصاعدة المرتبطة بالمناخ في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA). وهو يوفر أساساً ونقطة انطلاق للتعاون الاستراتيجي بين أصحاب الشأن الذين يعملون من أجل تحقيق رؤية شاملة للصحة النفسية والقدرة على تحمل تغير المناخ، مع توليد أدلة مستهدفة من خلال البحوث متعددة التخصصات. ومع ذلك، فإن تحقيق تقدم ملموس يتطلب قيادة مكرسة وموارد وإرادة سياسية إلى جانب مشاركة مستدامة وشاملة من جميع قطاعات المجتمع. وتسعى هذه الوثيقة إلى الإلهام من خلال إظهار الإمكانيات المتاحة إذا استنفدنا بشكل جماعي من المعرفة والتكنولوجيا والسياسات ونقاط القوة المجتمعية. ويستلزم المسار للمضي قدماً التغلب على العقبات المعقدة وإجراء تحولات في النظام والتي تتطلب جهداً متواصلًا. ومن خلال اتخاذ خطوات أولية طموحة تركز على التفاعل المتعاطف، على الرغم من القيد، يمكننا المضي قدماً نحو مستقبل تُقدَّر فيه صحة الناس والكوكب على حد سواء باعتبارهما مترابطين.

من قام بإعداد هذا التقرير

فريق التأليف

يضم فريق التأليف لهذا المشروع مجموعة متنوعة من المهنيين الذين ساهم كل منهم بخبرته الفريدة في تطوير العمل وإنجازه. د. ياروب عجلوني والذي عمل كمدير للمشروع ومنسق إقليمي للمشروع، حيث قام بتنسيق الفريق والتنسيق مع المتخصصين في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA). د. ضحى عمري والتي تولت دور المنسق الرئيسي، حيث أشرفت على توزيع المهام وتجميع العمل وقيادة عملية إنشاء المحتوى وصياغة جدول أعمال البحث. د. أشرف القضاة والذي كان مسؤولاً عن مراجعة التحليل البحثي والإشراف عليه، بالإضافة إلى التدقيق اللغوي ومراجعة جدول الأعمال النهائي. وقد عمل الدكتور نباز الميراني وفريقه من منظمة أطباء مساعدون للنشاطات الطبية (DAMA)، كمسؤولين إقليميين مشاركين، مما عزز الحوارات وساهم في تحديد النطاق الإقليمي وفهم السياق. د. طارق الجراح والذي قام بتيسير وتنسيق الحوارات وساعد في تسجيل التجارب الحية. مؤنس قدح ود. تالا دباس اللذان لعبا أدواراً رئيسية في التواصل وصياغة جدول الأعمال وتيسير المناقشات، بينما كان لبراء هيكل دوراً أساسياً في تيسير الحوارات وترجمة المحتوى. وقد كان للجهود التعاونية لهذا الفريق دور محوري في تشكيل اتجاه المشروع ونتائجه. إضافة إلى هذا الفريق، كان لسفير الشباب علاء عبد الجواد، سفير الشباب لدينا، دور حاسم في إشراك مجتمع الشباب وإعلاء وتوصيل أصواتهم على نطاق أوسع، حيث ساهم بشكل كبير في تيسير وتدوين الملاحظات ونشر محتوى المشروع في جميع أنحاء المنطقة.

شكر وتقدير

تم إنتاج محتوى هذا التقرير وملكيته الفكرية من خلال عملية تعاونية مع خبراء من شمال إفريقيا وغرب آسيا. ويعرب المؤلفون عن امتنانهم الشديد للخبرات والأصوات والأفكار المتنوعة التي قدمها أولئك الذين ساهموا في المحتوى المقدم في جدول أعمال البحث وهذا العمل. وتقع المسؤولية عن محتوى في هذا التقرير على عاتق المؤلفين، ولكننا نتشارك ملكية هذا العمل مع جميع هؤلاء المساهمين. ونود أن نُعرب عن تقديرنا للمساهمات التي قدمها:

- حمزة السعيد، حوار 1، حوار 2
- عامر محمد، حوار 1، حوار 2
- شيكاح المزين، حوار 1، حوار 2
- بشرى بلحاج عبد الله، حوار 1، حوار 2
- دانا درويش، حوار 1، حوار 2
- عماد حرايبي، حوار 1، حوار 2
- مرحة ليوا، حوار 1، حوار 2
- مازن ملكاوي، حوار 1، حوار 2
- منة زايد، حوار 1، حوار 2
- ميرنا البغدادي، حوار 1، حوار 2
- راشد مناع، حوار 1، حوار 2
- أوزما سليمان، حوار 1، حوار 2
- وسيم الديك، حوار 1، حوار 2
- علاء ضامن علي الفروخ، حوار 1، حوار 2
- آمنة عدنان وهيب، حوار 1، حوار 2
- بسمة طلبية، حوار 1، حوار 2
- حمزة عودة أحمد أبو صعييليك، حوار 1، حوار 2
- هدى عمران، حوار 1، حوار 2
- جاسم محمد أحمد، حوار 1، حوار 2
- كرم سعد سلمان، حوار 1، حوار 2
- كنزة خمصي، حوار 1، حوار 2
- مريم يوسف الشمالان، حوار 1، حوار 2
- نباز الميراني، حوار 1، حوار 2
- سرينا نايف محمد الشقيري، حوار 1، حوار 2

سعاد حسام ياسين طلافحة، حوار 1، حوار 2
تقى يونس حسن، حوار 1، حوار 2
صالح أحمد إرشيد، حوار 1، حوار 2
علياء ناصر الخلف، حوار 1، حوار 2
أدهم مارديني، حوار 2
فيليسيتي براون، حوار 2
مروة مهدي، حوار 2
ناتالي دويري، حوار 1، حوار 2
سمر المعلم، حوار 2

التمويل

قدمت مؤسسة (Wellcome) التمويل لهذا العمل.

تضارب المصالح

ليس لدى المؤلفين أي تضارب في المصالح للإعلان عنه.

الترجمات

مع الشكر لكاردينالات المناخ على الترجمة



لمحة عامة عن مشروع ربط العقلية المناخية

مشروع ربط العقلية المناخية (CCM) هو مشروع ممول من مؤسسة (Wellcome) والذي تم إطلاقه في عام 2023 لتطوير جدول أعمال شامل للبحث والعمل في مجال تغير المناخ والصحة النفسية. ويهدف المشروع إلى تحقيق هدفين رئيسيين متشابهين. الأول هو وضع جدول أعمال متناسق وشامل للبحث والعمل يركز على احتياجات أولئك الذين يعانون من تحديات الصحة النفسية في سياق تغير المناخ، لتوجيه المجال خلال السنوات القادمة. والثاني هو البدء بتطوير مجتمعات مترابطة من الممارسين في مجال تغير المناخ والصحة النفسية في سبع مناطق عالمية (محددة بأهداف التنمية المستدامة)، مجهزة لتفعيل جدول الأعمال هذا. نحن نهدف إلى الجمع بين نقاط القوة في المنظور العالمي والتركيز الإقليمي، والجمع بين وجهات النظر التخصصية المتنوعة في رؤية مشتركة يمكن أن تضمن فعالية البحوث في معالجة الثغرات في الأدلة ذات الأولوية والإحاطة بالتغيرات في السياسات والممارسات عند تقاطع تغير المناخ مع الصحة النفسية.

هيكل الفريق المجتمعي الإقليمي

في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، يتولى قيادة مشروع ربط العقلية المناخية الفريق المجتمعي الإقليمي (RCT)، المسؤول عن جمع الخبرات المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة وبناء القدرات الإقليمية لإنشاء وتفعيل أجندة البحث والعمل. ويرد أدناه موجز لهيكلية تجربة البحث عن النتائج.

الاعضاء	الدور	هيكل الفريق المجتمعي الإقليمي
جمعية العون الصحي الأردنية - الدولية، الأردن د. ياروب عجلوني د. ضحي العمري د. تالا دباس مؤنس القضاة	مسؤول عن تطوير وتنفيذ أنشطة المشروع في المنطقة، بما في ذلك عقد ودعم المجتمع الإقليمي من الخبرات المتنوعة.	المنسق المجتمعي الإقليمي (RCC)
د. روبا كاترينا، طبيبة نفسية، سوريا د. نياز ميراني، منظمة أطباء مساعدون للنشاطات الطبية (DAMA)، العراق مازن ملكاوي، المستشار الإقليمي للصحة البيئية في منظمة الصحة العالمية (WHO)، مكتب إقليم شرق المتوسط (EMRO)، المركز الإقليمي للعمل الصحي البيئي (CEHA)، الأردن	تقديم خبرات إضافية واسعة النطاق في مختلف التخصصات والبلدان، وتقديم المشورة الفنية والمراجعة، ودعم تنفيذ المشاريع.	الشركاء في عقد الاجتماعات
أشرف ف. القضاة، أستاذ مشارك في علم النفس الطبي الإكلينيكي، الأردن الدكتور حمد الغافري، طبيب استشاري بالصحة	مجلس استشاري من الخبراء من ذوي التجارب المعيشية في تحديات الصحة النفسية في سياق تغير المناخ أو الذين ينتمون إلى الفئات السكانية الضعيفة ويعيشون مع المخاطر المناخية. وبالإستفادة من خبراتهم وحكمتهم الفريدة، تقدم مجموعات الخبراء	المجموعة الاستشارية للتجارب الحية (LEAG)

القانونيين وجهات نظر وتوجيهات حيوية تركز على المجتمع المحلي وتسترشد بالنهج الشامل للمشروع ومخرجاته.	العامه، الإمارات العربية المتحدة مريم الشملان، وزارة الصحة القطرية، قطر شذى بني صخر، باحثة / عالمة نفسية، الأردن كرم سعد سلمان، مستشار في وزارة الصحة والسكان والدعم الاجتماعي، العراق
المستشارون الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً) ممن لديهم خبرة معيشية في تحديات الصحة النفسية في سياق تغير المناخ أو ينتمون إلى الفئات السكانية الضعيفة ويعيشون مع المخاطر المناخية. سفير (سفراء) الشباب والذين يجلبون وجهات نظر فريدة تركز على الشباب في تطوير وتنفيذ أنشطة المشروع.	سفير (سفراء) الشباب (YAs)

الأساليب

لقد وضعنا جدول أعمال البحث والعمل هذا من خلال منهجية قوية وشاملة للنقاط ودمج وصفل مجموعة متنوعة غنية من وجهات النظر مع تعزيز التواصل عبر مجتمع الممارسة المتنامي. وقد اجتمع خبراء من مختلف التخصصات والقطاعات والبلدان في حوارين افتراضيين وتم التشاور معهم من خلال استبيانيين عبر الإنترنت.

وقد قام الفريق الأساسي بمشروع ربط العقلية المناخية بتطوير هذه المنهجية على المستوى العالمي بالتشاور مع الفريق المجتمعي الإقليمي والمجلس الاستشاري العالمي ومؤسسة (Wellcome). وتم تكييف الأساليب والمواد على المستوى الإقليمي من قبل فريق البحث الإقليمي لضمان التوازن بين التوحيد العالمي والملاءمة والمرونة الإقليمية. وقد سهلت المشاركة المستمرة بين المناطق للعمليات والدروس المستفادة والتحديات التطوير التكراري للمنهجية. وفيما يلي عملية تطوير ووضع جداول أعمال البحث والعمل الإقليمية.

تم تعيين المشاركين أولاً من خلال شبكات الفريق المجتمعي الإقليمي، والفريق الأساسي بمشروع ربط العقلية المناخية ومؤسسة (Wellcome)، مع المزيد من التوظيف من خلال أخذ العينات بطريقة كرة الثلج للوصول إلى مجموعة واسعة من الخبراء عبر التخصصات والقطاعات والمناطق الجغرافية.

ويمكن العثور على الطرق الكاملة [هنا](#).

جدول الأعمال العالمي للأبحاث والإجراءات	تحسين أولويات البحث	تحديد المجالات ذات الأولوية للبحث	تحديد النطاق وتحديد السياق	تحديد النطاق العالمي والتطوير
تشكيل فريق عمل لخبراء التحليل العالمي تجميع سبعة جداول أعمال إقليمية، وجدول أعمال الشعوب الأصلية، وجدول أعمال الشباب، وجدول أعمال صغار المزارعين وصيادي الأسماك في مشروع جدول أعمال عالمي. حدث عالمي لجمع الخبراء لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال البحث والعمل العالمي والموافقة عليه	الحوار الثاني مع الخبراء الإقليميين للحصول على ردود الفعل بشأن أولويات البحث وتحديد مسارات تنفيذ البحوث وترجمتها تحليل وتجميع البيانات من الحوار الثاني لتحسين أولويات البحث دراسة استقصائية مع خبراء إقليميين لتبادل أولويات البحث المكررة، والحصول على مزيد من ردود الفعل والمنذات الإقليمية الأوسع الاستعراض والتشاور مع الخبراء الإقليميين والعالميين تحديد مسارات تفعيل البحوث وترجمة الأدلة إلى أفعال تحليل وتجميع البيانات من الحوار الثاني لتحديد مسارات تنفيذ البحوث وترجمتها بناء مجتمع الممارسة الإقليمي	الحوار الأول مع خبراء إقليميين متنوعين لعرض الاحتياجات ذات الصلة ومناقشة أولويات البحث تحليل وتجميع البيانات من الحوار الأول لتوليد مسودة أولويات البحث	جمع منظور التجربة المعيشية استعراض نطاق الأدبيات الموجودة على المستوى الإقليمي رسم خرائط مخاطر المناخ المقابلات مع مصادر المعلومات الرئيسية دراسة استقصائية ما قبل الحوار مع الخبراء الإقليميين المدعوين إلى الحوار	رسم خرائط أصحاب الشأن والتخصصات ذات الصلة مراجعة قاعدة الأدلة الأكاديمية الحالية ومعالم السياسات وضع إطار عالمي لفئات البحوث تشكيل مجلس استشاري عالمي لتقييم المشورة بشأن وضع جدول أعمال للبحث والعمل على الصعيد العالمي والإقليمي
يناير - أبريل 2024	أكتوبر - ديسمبر 2023	أغسطس - أكتوبر 2023	مارس - سبتمبر 2023	يناير - مارس 2023

تحديد أولويات البحث والعمل

تم وضع أولويات البحث وتنقيحها ووضع اللمسات الأخيرة عليها من خلال العملية التالية:

- تطوير فئات البحث: ومن خلال عملية تنسيق شاملة لمراجعات تغيير المناخ والصحة النفسية القائمة ذات الصلة،^{4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14} تم تحديد أربع فئات بحثية واسعة النطاق كمجالات تحتاج إلى مزيد من العمل على الصعيد العالمي. وقد استُخدم هذا الإطار كأساس لهيكلية المناقشات داخل الحوارات لتوليد أولويات البحث وتشكيل إطار الترميز العالمي للتحليل. وكانت هذه:
 - الآثار والمخاطر والفئات الهشة: لتحسين فهمنا لطرق تأثير الصحة النفسية بتغير المناخ. على سبيل المثال: ما هي نتائج الصحة النفسية المتأثرة أو المعرضة للخطر؛ ومدى انتشار هذه الآثار وشدها وتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن هم الأكثر عرضة لهذه الآثار.
 - المسارات والآليات: تحسين فهمنا لكيفية تأثير الصحة النفسية بتغير المناخ، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت هناك عوامل خاصة بتغير المناخ تزيد من مخاطر الصحة النفسية. ويشمل ذلك النظر في المسارات والآليات البيولوجية والنفسية والاجتماعية والبيئية.
 - فوائد الصحة النفسية للإجراءات المتعلقة بالمناخ (التكيف والتخفيف من حدة تغير المناخ): إن فهم وقياس متى وكيف يمكن أن تكون إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، عبر القطاعات، مفيدة للجميع في مجال الصحة النفسية.
 - تدخلات / حلول الصحة النفسية في سياق تغير المناخ: تحديد التدخلات / الحلول / الإجراءات الأكثر فعالية في مجال الصحة النفسية لدعم الصحة النفسية في سياق تغير المناخ، بمختلف القطاعات. ويشمل ذلك تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون بالفعل من آثار سلبية على الصحة النفسية والحد من المخاطر أو شدة الآثار السلبية على الصحة النفسية في المستقبل.
- استحداث المحاور البحثية ذات أولوية: تم توجيه المشاركين في الحوار 1 من خلال مناقشة منظمة لإظهار وجهات نظرهم حول (1) العواقب الناشئة والمحتملة على الصحة النفسية للمخاطر المناخية الحالية والمستقبلية ذات الصلة إقليمياً والفرص المتاحة لفوائد الصحة النفسية للعمل في مجال الصحة النفسية والمناخ، و(2) المجالات التي تحتاج إلى مزيد من البحث لفهم العواقب والفرص المحددة والاستجابة لها.
- التحليل: تم تحليل بيانات الحوار (نصوص غرف الاستراحة والملاحظات) باستخدام المنهج الإطاري¹⁴ - وهو منهج قائم على المصفوفة يسمح للباحثين النوعيين بإجراء استجواب عميق للنصوص والملاحظات المكتوبة.
- مسودة المحاور البحثية ذات الأولوية: وقد استُخدمت هذه المصفوفة إلى جانب البيانات المستقاة من تحديد النطاق قبل الحوار (المقابلات / مراجعة الأدبيات / الاستبيان السابق للحوار) التي أجريت في المنطقة لصياغة قائمة بمحاور البحث ذات الأولوية. وتم تنقيحها من خلال التشاور مع فريق البحث والتقييم والتثليل عبر الملاحظات الجانبية والنصوص وتحديد النطاق قبل الحوار واستشارة الخبراء.
- تنقيح محاور البحث ذات الأولوية: تمت مشاركة محاور البحث مع المشاركين في الحوار 2 للحصول على ملاحظاتهم وردود الفعل. وقد تم تنقيح محاور البحث استجابةً لهذه الملاحظات ومشاركتها مع المشاركين في الحوار وعينة أوسع من الخبراء في الاستبيان الذي أعقب الحوار.

- وضع اللمسات الأخيرة على المحاور البحثية ذات الأولوية: تم وضع القائمة النهائية لمحاور البحث ذات الأولوية بناءً على دمج ردود الفعل على الاستبيان التي أعقبت الحوار، والتشاور مع الفريق المجتمعي الإقليمي والخبراء الإقليميين، والفريق الأساسي بمشروع ربط العقلية المناخية، والمجلس الاستشاري العالمي ومؤسسة (Wellcome).

تم تحديد أولويات العمل وتنقيحها ووضع اللمسات الأخيرة عليها من خلال العملية التالية:

- تطوير فئات العمل: ومن خلال التشاور مع الخبراء في الفريق العالمي بمشروع ربط العقلية المناخية، تم تحديد فئتين رفيعتي المستوى للإجراءات ذات الأولوية. وكانت هذه: (1) تهيئة بيئة مواتية للبحث في مجال التقاطع بين تغير المناخ والصحة النفسية و(2) ترجمة قاعدة الأدلة المتنامية إلى إجراءات يمكن أن تستجيب لأثار تغير المناخ على الصحة النفسية. وضمن كل فئة، كانت الفئات الفرعية هي: (1) الحالة المستقبلية المنشودة، (2) الفرص والعوامل المساعدة، (3) التحديات، (4) الشركاء وأصحاب الشأن.
- استحداث الإجراءات ذات الأولوية: تم توجيه المشاركين في الحوار 2 من خلال مناقشة منظمة لإبراز وجهات نظرهم حول (1) كيف يمكن تنفيذ جدول أعمال الأبحاث المتعلقة بتغير المناخ وأبحاث الصحة النفسية على أفضل وجه في المنطقة و(2) كيف يمكن ترجمة قاعدة الأدلة المتنامية إلى إجراءات في السياسات والممارسات.
- التحليل: تم تحليل بيانات الحوار (نصوص الغرف الجانبية والمذكرات) باستخدام المنهج الإطاري (كما هو موضح أعلاه).
- وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات ذات الأولوية: تم وضع جدول عمل يلخص الأفكار المستقاة من الحوار الثاني ويحدد الإجراءات ذات الأولوية المحددة بناءً على التشاور مع الفريق المجتمعي الإقليمي والخبراء الإقليميين، والفريق الأساسي بمشروع ربط العقلية المناخية، والمجلس الاستشاري العالمي ومؤسسة (Wellcome).

المشاركون

كان المشاركون في الحوار مجموعة متنوعة من حيث الانتشار الجغرافي والنوع الاجتماعي والقطاعي والتخصصي. وتمت دعوة جميع المشاركين إلى كلا الحوارين، ولكن في بعض الحالات لم يتمكن المشاركون من حضور الحوارين معاً.

في المجمل، حضر 50 مشاركاً الحوار الأول، و31 مشاركاً حضروا الحوار الثاني. ويوفر الجدولان أدناه توزيعاً لخصائص المشاركين.

الانتشار الجغرافي

البلد	الحوار الأول		الحوار الثاني	
	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
مصر	7	16%	4	17.0%
فرنسا	0	0%	1	4.3%
العراق	8	18.6%	5	22%
الأردن	14	32.6%	5	22%
لبنان	1	2%	0	0%
المغرب	2	5%	2	9%
قطر	1	2%	0	0%
المملكة العربية السعودية	2	5%	1	4.3%
دولة فلسطين	1	2%	0	0%

13%	3	7%	3	تونس
4.3%	1	5%	2	الإمارات العربية المتحدة
4.3%	1	5%	2	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

الخبرة

الحوار الثاني		الحوار الأول		الخبرة
النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	
35%	13	33%	23	تغير المناخ
27%	10	24%	17	الصحة النفسية
30%	11	31.4%	22	الرعاية الصحية
8%	3	11.4%	8	أخرى
0%	0	0%	0	لا أعلم / أفضل عدم الإفصاح

التخصص

الحوار الثاني		الحوار الأول		التخصص
النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	
7%	6	12%	15	نشطاء
16%	13	12%	15	المجتمعات المحلية
10%	8	13%	17	التعليم
6%	5	6%	8	خبير من خلال تجربتي الحياتية الشخصية
2.4%	2	2%	3	التمويل
12%	10	12%	16	الرعاية الصحية
16%	13	12%	15	منظمة غير حكومية
10%	8	8%	11	السياسة
18%	15	21%	27	البحث
2.4%	2	2%	3	أخرى

الحوار الأول		الحوار الثاني		النوع الاجتماعي
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	
6	24%	2	12.50%	رجال
17	68%	12	75%	نساء
2	8%	2	12.50%	أخرى

المشاركون في الاستبيان:iii

استبيان ما قبل الحوار: 68

استبيان ما بعد الحوار: 24

الأخلاقيات وجمع البيانات وتخزينها

الأخلاقيات

تمت مراجعة هذه الدراسة ومُنحت رأياً إيجابياً أخلاقياً من قبل لجنة الأخلاقيات البحثية في كلية إمبريال (عنوان الدراسة: "حوارات عالمية لوضع جدول بحثي قابل للتطبيق وبناء مجتمع ممارسات في مجال تغير المناخ والصحة النفسية"؛ رقم معرف الدراسة: 6522690).

تخزين البيانات ومشاركتها

أجريت الحوارات افتراضياً على تطبيق زووم (Zoom) وذلك بعد الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين. وتم تسجيل الحوارات والمجموعات الجانبية وتدوينها من قبل مزودي خدمات خارجيين (شركة (Way with Words) وشركة (Absolute Translations)). وتم توزيع الاستبيان وجمع البيانات باستخدام منصة (Qualtrics) الإلكترونية. وتم تخزين البيانات وإدارتها بواسطة كلية إمبريال في لندن باستخدام خادم آمن. وقد كانت جمعية العون الصحي الأردنية - الدولية مشتركة في التحكم في البيانات المقدمة لهذا المشروع لمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، وكانت مسؤولة عن التخزين الآمن للبيانات ومشاركتها مع كلية إمبريال في لندن وفرق التحليل الإقليمية. وسيتم تخزين البيانات بواسطة كلية إمبريال في لندن لمدة 10 سنوات بعد انتهاء الدراسة.

ملخص الأبحاث الحالية حول تغير المناخ والصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق (NAWA/MENA) الأوسط وشمال إفريقيا)

يمثل التقاطع بين تغير المناخ والصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) تحدياً معقداً، حيث أن تزايد التأثيرات المناخية والضغطات البيئية تفاقم من نقاط الضعف الموجودة مسبقاً لدى الأفراد والمجتمعات. ولم يتمكن المنسق المجتمعي الإقليمي من تحديد الدراسات من بلدان المنطقة والتي تسلط الضوء على الطرق متعددة الأوجه التي يؤدي فيها تغير المناخ إلى تفاقم مشاكل الصحة النفسية في هذه المنطقة، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من البحوث الموجهة والتدخلات التكيفية. وقد أظهرت الدراسات أن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) معرضة بشكل خاص لندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب الظواهر المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة¹⁶¹⁵، وتشكل هذه الضغوطات خطراً على نتائج الصحة النفسية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى استراتيجيات شاملة لبحث هذه التحديات ومعالجتها علاوة على ذلك، فإن تفاقم عدم الاستقرار السياسي

ⁱⁱⁱيرجى ملاحظة أن الأرقام تقريبية ولا تأخذ في الحسبان الردود المكررة أو غير المكتملة.

بسبب الضغوطات المناخية يشكل خطراً آخر على منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)¹⁷. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة أعباء الصحة النفسية، حيث أن عدم اليقين والاضطرابات الاجتماعية وبالتأكيد النزاعات المسلحة يمكن أن تسهم في الضيق النفسي وتزيد من انتشار تحديات الصحة النفسية.¹⁸ كما قد تلعب الآثار غير المباشرة لتغير المناخ، مثل الانكماش الاقتصادي والهجرات القسرية بسبب التدهور البيئي، دوراً حاسماً في تشكيل نتائج الصحة النفسية، مما يسلط الضوء على تقاطع المحددات البيئية والاجتماعية للصحة في سياق منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA).

تتطلب معالجة الصحة النفسية في مواجهة التغير المناخي في إطار منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA) فهماً دقيقاً لهذه الروابط المتبادلة، وهو أمر مفقود إلى حد كبير في الأدبيات الحالية. وهناك ضرورة واضحة للتدخلات التي لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الفورية للصحة النفسية فحسب، بل تراعي أيضاً السياسات البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقاً للتخفيف من الآثار الطويلة الأجل لتغير المناخ على الصحة النفسية والرفاه. وهناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات متكاملة للصحة النفسية والقدرة على تحمل تغير المناخ، والتي تكون مصممة خصيصاً لتلائم التحديات الفريدة التي تواجهها المجتمعات المحلية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NAWA/MENA)، بما يضمن أن تكون أنظمة دعم الصحة النفسية قوية ومتاحة وقادرة على معالجة الآثار المركبة لتغير المناخ.

مسرد المصطلحات

إن تغير المناخ والصحة النفسية وتقاطعهما مجالان معقدان وواسعا النطاق. وبالنسبة لجدول الأعمال هذا، نحدد نطاق هذه المصطلحات على النحو التالي.

ونعني بتحديات الصحة النفسية الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي تؤثر على قدرة الشخص على العمل في مجال أو أكثر من مجالات الحياة وغالباً ما تنطوي على مستويات كبيرة من الضيق النفسي. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القلق والاكتئاب والإجهاد اللاحق للصدمة والذهان والأفكار الانتحارية وإساءة استخدام المواد المخدرة.

ونعني بالتجارب المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ: (1) التعرض لتأثيرات مباشرة للمخاطر المناخية، مثل موجات الحر الأكثر تواتراً وشدة، أو حرائق الغابات / حرائق الأحرار، أو الجفاف، أو الفيضانات أو العواصف (مثل الأعاصير المدارية، والأعاصير، والزوابع)، و(2) التعرض لاضطراب المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة النفسية الجيدة، مثل الاضطراب إلى الانتقال من المنزل، أو عدم القدرة على الحصول على الغذاء أو الماء، أو فقدان سبل العيش أو الأوطان، أو اضطراب الممارسات الثقافية نتيجة لتغير المناخ.

تشمل تحديات الصحة النفسية في سياق تغير المناخ ما يلي:

- كيف يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم تحديات الصحة النفسية الموجودة لدى الفرد من قبل.
- كيف يمكن لتغير المناخ أن يسهم في انتشار أو وطأة تحديات الصحة النفسية الحالية.
- كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على إمكانية الحصول على العلاج أو فعاليته لمن يعانون من تحديات الصحة النفسية.
- كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤدي إلى تحديات جديدة في مجال الصحة النفسية.

للحصول على مسرد مصطلحات يصف المفاهيم والكلمات الرئيسية ذات الصلة بجدول أعمال البحث والعمل الخاصة بربط العقول المناخية، يرجى تنزيله [من هنا](#).

- Ajlouni, Y. *et al.* *Regional research and action agenda: Middle East and Northern Africa*. (Wellcome, 2024).¹
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (Cambridge University Press, 2023).²
- Knutson, T. *et al.* Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II: Projected Response to Anthropogenic Warming. *Bulletin of the American Meteorological Society* **101**, E303–E322 (2020).³
- Lawrance, E. L., Thompson, R., Newberry Le Vay, J., Page, L. & Jennings, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and its Implications. *Int Rev Psychiatry* **34**, 443–498 (2022).⁴
- Corvalan, C. *et al.* Mental health and the global climate crisis. *Epidemiol Psychiatr Sci* **31**, (2022).⁵
- Charlson, F. *et al.* Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. *IJERPH* **18**, 4486 (2021).⁶
- Hwong, A. R. *et al.* Climate change and mental health research methods, gaps, and priorities: a scoping review. *Lancet Planet Health* **6**, e281–e291 (2022).⁷
- Charlson, F. *et al.* Global priorities for climate change and mental health research. *Environ Int* **158**, 106984 (2022).⁸
- Crandon, T. J. *et al.* The clinical implications of climate change for mental health. *Nat Hum Behav* **6**, 1474–1481 (2022).⁹
- Cianconi, P., Betrò, S. & Janiri, L. The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review. *Front Psychiatry* **11**, (2020).¹⁰
- Berry, H. L., Bowen, K. & Kjellstrom, T. Climate change and mental health: a causal pathways framework. *Int J Public Health* **55**, 123–132 (2010).¹¹
- Aylward, B., Cunsolo, A., Vriezen, R. & Harper, S. L. Climate change is impacting mental health in North America: A systematic scoping review of the hazards, exposures, vulnerabilities, risks and responses. *Int Rev Psychiatry* **34**, 34–50 (2022).¹²
- Lebel, L. *et al.* Climate change and Indigenous mental health in the Circumpolar North: A systematic review to inform clinical practice. *Transcult Psychiatry* **59**, 312–336 (2022).¹³
- Gale, N. K., Heath, G., Cameron, E., Rashid, S. & Redwood, S. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. *BMC Med Res Methodol* **13**, (2013).¹⁴
- Namdar, R., Karami, E. & Keshavarz, M. Climate Change and Vulnerability: The Case of MENA Countries. *IJGI* **10**, 794 (2021).¹⁵
- Al-Delaimy, W.K. Vulnerable populations and regions: Middle East as a case study. *Health of People, Health of Planet and Our Responsibility: Climate Change, Air Pollution and Health*. 121-133 (2020).¹⁶
- Sofuoğlu, E. & Ay, A. The relationship between climate change and political instability: the case of MENA countries (1985:01–2016:12). *Environ Sci Pollut Res* **27**, 14033–14043 (2020).¹⁷
- Carpiniello, B., 2023. The Mental Health Costs of Armed Conflicts—A Review of Systematic Reviews Conducted on Refugees, Asylum-Seekers and People Living in War Zones. *International journal of environmental research and public health*, **20**(4), 2840.¹⁸